

ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Κατά τη θητεία ως ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου ή ως ιατροί της ΠΦΥ, θα βρεθούμε στη θέση να διαχειριστούμε μια τηλεφωνική κλήση για κάποιο επείγον ή έκτακτο συμβάν στην οικία του ασθενούς, στο χώρο εργασίας, στο αγρόκτημα ή όπου αλλού. Η διαχείριση μιας τηλεφωνικής κλήσης για ένα ιατρικό περιστατικό απαιτεί πρωταρχικά, ψυχραιμία από πλευράς προσωπικού που δέχεται την κλήση και δεξιότητες σε ό,τι αφορά στον κατευνασμό του άγχους, της ανησυχίας, ενίοτε του τρόμου του καλούντος, τη λήψη επαρκών και ορθών πληροφοριών για το σημείο και τις συνθήκες του συμβάντος και την κλινική κατάσταση του ασθενούς, καθώς επίσης και την πιθανή παροχή απλών, κατανοητών οδηγιών για την προσωρινή αντιμετώπιση του ασθενούς μέχρι αφίξεως της ιατρικής αρωγής με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) ή με όχημα και πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ (βλ. σελ. 375).

Έτσι, κατά την άφιξή μας στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασθενής, ελέγχουμε πρωτίστως για την ασφάλεια του χώρου (*ασφάλεια σκηνής*) οργανώνοντας ένα ασφαλές περιβάλλον (*φοράμε γάντια, μάσκα, γυαλιά, κ.ά., απομακρύνουμε επικίνδυνα αντικείμενα*) ανάλογα με τις συνθήκες. Παράλληλα, ελέγχουμε με μια γρήγορη ματιά, τον περιβάλλοντα χώρο για ανεύρεση στοιχείων που πιθανώς να μας βοηθήσουν στη διάγνωση (*π.χ. κουτιά χαπιών, συσκευές μέτρησης γλυκόζης, φορητές συσκευές οξυγόνου, μαγκάλι, σπασμένα παράθυρα, παραβιασμένη πόρτα, δοχεία χημικών ή άλλων ουσιών, κ.ά.*). Εφόσον ο ασθενής ή το θύμα έχει τη δυνατότητα να μας δώσει πληροφορίες, λαμβάνουμε ένα σύντομο ιστορικό για τη νόσο ή το ατύχημα συμβάν που τον οδήγησε στην έκκληση βοήθειας, διαφορετικά αντλούμε πληροφορίες από τους οικείους ή περιοίκους για το ιστορικό και την πρόσφατη επιδείνωση της υγείας που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση και την αναζήτηση βοήθειας.

Ακολουθώντας, ξεκινούμε την κλινική εξέταση και αντιμετώπιση του ασθενούς έχοντας πάντοτε κατά νου τον αλγόριθμο Α-Β-С-D-Ε. Έτσι, με γνώμονα τον αλγόριθμο αυτόν:

- A.** Αξιολογούμε τον αεραγωγό και την αναπνοή. Ελέγχουμε για πιθανά σημεία απόφραξης του αεραγωγού (*π.χ. θέση σώματος, εισπνευστικός συριγμός, ύπαρξη ξένων σωμάτων ή εμεσμάτων στο στόμα, οίδημα λάρυγγα, κ.ά.*). Εφόσον ο ασθενής ομιλεί ο αεραγωγός θεωρείται βατός. Σε περιπτώσεις τραυματισμού – ειδικά της κεφαλής και του αυχένα – μεριμνούμε, πριν από οποιονδήποτε άλλο χειρισμό, για την προστασία της ΑΜΣΣ με ακινητοποίηση της κεφαλής και προσεκτική τοποθέτηση σκληρού αυχενικού κηδεμόνα («κολλάρου») τύπου Philadelphia (βλ. σελ. 252, κεφ. 19 - «Πολυτραυματίας ασθενής»).
- B.** Ελέγχουμε την οξυγόνωση (SpO_2) και την αναπνευστική λειτουργία («Κοίτα - Άκου - Νιώσε»: *ύπαρξη σημείων κυάνωσης, αναπνευστική συχνότητα, συμμετρία ημιθωρακίων, εύρος και ποιότητα αναπνοής, παθολογικοί ήχοι, παρεκτόπιση της τραχείας, υποδόριο εμφύσημα, διάταση σφαγιτίδων, κ.ά.*). Προσοχή απαιτείται σε ασθενείς σε shock ή με υποθερμία, όπου ο έλεγχος του κορεσμού O_2 στα δάκτυλα δεν θεωρείται αξιόπιστος.
- C.** Αξιολογούμε τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος:
 - ♦ Ελέγχουμε την καρδιακή λειτουργία και την καρδιακή συχνότητα (*έλεγχος σφυγμού, ακρόαση, εκτέλεση ΗΚΓ ή συνεχές monitoring ΗΚΓφικού ρυθμού, σφύξεων και ΑΠ*).
 - ♦ Μετράμε την ΑΠ κι από τους δύο βραχίονες και την ελέγχουμε τακτικά ή συνεχώς.
 - ♦ Μετράμε τον χρόνο τριχοειδικής επαναπλήρωσης (φυσιολογικά, $XTE < 2 \text{ sec}$).
 - ♦ Ελέγχουμε για σημεία αιμορραγίας και αντιμετωπίζουμε άμεσα τις σοβαρές ή τις απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες (*αιμόσταση, ίσχαιμη περίδεση, φλεβοκέντηση*).
 - ♦ Εφόσον ο ασθενής φέρει μόνιμο ουροκαθετήρα, ελέγχουμε την εικόνα των ούρων, καθώς και την ποσότητα και το ρυθμό αποβολής ούρων στον ουροσυλλέκτη.
- D.** Ελέγχουμε το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς με την κλίμακα AVPU ή την GCS. Μετράμε τα επίπεδα γλυκόζης. Εξετάζουμε τις κόρες των οφθαλμών (*μυδρίαση ή μύση, ανισοκορία, φωτοκινητικό αντανακλαστικό*). Εκτελούμε έναν αδρό νευρολογικό έλεγχο. Ελέγχουμε επίσης για σημεία ή συμπτώματα συστηματικής δηλητηρίασης (τοξίκωση).

Ε. Εξέταση «από την κορυφή έως τα νύχια» με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ασθενούς. Θερμομέτρηση. Έλεγχος, συνολικά, κορμού και άκρων για κακώσεις, αιματώματα, εκδορές, οιδήματα, εξανθήματα, έλκη, κατακλίσεις, νυγμούς βελονών, σημεία σήψης ή φλεγμονής. Σε περιπτώσεις υποθερμίας μεριμνούμε πρωτίστως για την επαναθέρμανση του ασθενούς, αλλά και για την προφύλαξή του από τον κίνδυνο υποθερμίας.

Αφού ολοκληρώσουμε την κλινική εξέταση και την αρχική πρωτογενή εκτίμηση και αξιολόγηση του ασθενούς, αρχίζει να μορφοποιείται αδρά στο μυαλό μας ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει τις 2-3 πιθανότερες κλινικές διαγνώσεις για το περιστατικό που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Εφαρμόζουμε τη θεραπευτική παρέμβαση σύμφωνα με τους εκάστοτε κλινικούς αλγορίθμους που αφορούν στη διαφαίνουσα κλινική κατάσταση.

Στη συνέχεια, ενημερώνουμε τηλεφωνικά το αρμόδιο προσωπικό του ΚΥ (*συνήθως τον εφημερεύοντα ειδικό ιατρό*) ή το ΤΕΠ του νοσοκομείου υποδοχής, για τη φύση, τη βαρύτητα του περιστατικού, τις σκέψεις και τις ενέργειές μας, ενώ λαμβάνουμε οδηγίες εφόσον αυτό απαιτηθεί από τη σοβαρότητα ή τις όποιες ειδικές συνθήκες του συμβάντος.

Με βάση τα ανωτέρω, θα αποφασίσουμε τελικά το επόμενο βήμα δράσεως για τον ασθενή μας. Αν δηλαδή θα εφαρμοστεί θεραπευτική αγωγή κατ' οίκον, αν διακομιστεί στο ΚΥ για ενδεδειγμένο έλεγχο (*εργαστηριακά, ακτινογραφίες, υπερηχ/φωμα*), σταθεροποίηση και αντιμετώπιση ή αν κριθεί αναγκαίο να διακομισθεί τελικά στο νοσοκομείο (*βλ. σελ. 371*).

Πρέπει να τονιστεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις – *ειδικά όταν το νοσοκομείο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση ή όταν η διακομιδή εκτελείται άνευ συνοδείας ιατρού με απλό πλήρωμα του ΕΚΑΒ* – ίσως κριθεί επιβεβλημένη η αρχική μεταφορά στο ΚΥ, ενός βαρέως πάσχοντος ασθενούς, για προσωρινή αντιμετώπιση και σταθεροποίηση. Παρότι αυτό, με μια πρώτη ματιά, πιθανώς να θεωρηθεί ως περιττή χρονοτριβή, τελικά εξασφαλίζει τόσο στον ασθενή, όσο και στον διακομίζοντα ιατρό και στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, τις πλέον ιδανικές συνθήκες για ομαλή, ασφαλή, χωρίς σοβαρά απρόοπτα διακομιδή ως τον τελικό προορισμό.



Φαρμακευτική αγωγή κατ' οίκον – Παροχή οδηγιών στον ασθενή ή τους φροντιστές.

Σε αρκετές περιπτώσεις στην ΠΦΥ, μετά από επίσκεψη σε ασθενή κατ' οίκον – *για ένα περιστατικό για το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έχρηζε διακομιδής και νοσηλείας* – θα χρειαστεί να παράσχουμε φαρμακευτική αγωγή για ορισμένο χρονικό διάστημα και οδηγίες (*π.χ. ελάσσονα λοίμωξη, ελαφρά τραύματα, τοποθέτηση ή αλλαγή ουροκαθετήρα, περιποίηση κατακλίσεων, ελκών ή στομιών, διενέργεια προγραμματισμένων ενεσσοθεραπειών για γνωστή χρόνια ή ανίατη νόσο, τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα σίτισης, κ.λπ.*). Στις περιπτώσεις αυτές φροντίζουμε ώστε η φαρμακευτική αγωγή, το πρόγραμμα θεραπειών, καθώς και οι λοιπές ιατρικές οδηγίες να γίνουν απολύτως κατανοητές από τον ασθενή μας.

Σε άλλες ειδικές περιπτώσεις που ο ασθενής δεν είναι σε θέση να λάβει γνώση ή να κατανοήσει τις οδηγίες μας για τη φαρμακευτική αγωγή, μεριμνούμε ώστε να ενημερωθεί επαρκώς κάποιο οικείο, συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, που επιφορτίζεται με τη φροντίδα του ασθενούς. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως χρειαστεί να είμαστε σε τακτική επικοινωνία με τους φροντιστές για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και να τους διαβεβαιώσουμε ότι ανά πάσα στιγμή είμαστε στη διάθεσή τους για πιθανή επανεκτίμηση του ασθενούς και πιθανώς για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, εφόσον η κατάσταση δεν βελτιωθεί ή επιδεινωθεί.

Εν κατακλείδι, η προσέγγιση ενός ασθενούς κατ' οίκον, είτε για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο λόγω μιας μείζονος κλινικής κατάστασης ή επιδείνωσης υπάρχουσας νόσου, είτε για τη θεραπευτική αντιμετώπιση οίκοι, απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες από τον ιατρό, που καλείται σε ένα περιβάλλον άγνωστο, χωρίς μέσα και υποστήριξη να λάβει κλινικές αποφάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα και πολλές φορές υπό αφόρητη πίεση από το οικείο περιβάλλον του ασθενούς. Στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις – *τις στιγμές της ανάγκης ή του πόνου, όπου ο ασθενής ή οι οικείοι ζητούν ιατρική βοήθεια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ή την «πολυτέλεια» της επιλογής ιατρού* – ας αναλογιστούμε το μέγεθος του λειτουργήματος που επιτελούμε και **«ας είμαστε ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον ασθενή μας!»**